



GUIA PARA PACIENTES

Tendão de Aquiles dolorido: o que fazer, o que evitar e quando procurar ajuda

a tendinopatia do Aquiles explicada por um ortopedista

A dor no tendão de Aquiles costuma responder a exercício bem dosado, e não a repouso. Entenda os dois tipos de dor, os sinais de ruptura e o que a ciência diz sobre cada tratamento.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **AQUILES**

Para quem é:

Para quem sente dor **na parte de trás do tornozelo ou do calcanhar**, no tendão de Aquiles, que começou **aos poucos**, piora com caminhada, corrida, salto ou escada, e **não tem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem sentiu um **estalo** ou uma "pedrada" atrás da perna: primeiro, avaliação.
- Quem operou o tendão: siga a orientação da sua equipe.
- Quem tem doença reumática, diabetes descontrolado ou usa corticoide há muito tempo: converse com seu médico antes de começar.

O que você vai precisar:

- Um degrau firme, com corrimão ou parede para apoio.
- Uma cadeira firme, sem rodinhas.
- Uma mochila, para colocar peso mais à frente.
- Uma caneta para o rastreador da Página 8.

Regra de ouro:

Incômodo **leve** no tendão durante o exercício: aceitável. Dor que **não passa até a manhã seguinte** ou que **piora de uma semana para a outra**: reduza.

Estalo, "pedrada" ou perda de força para ficar na ponta do pé: **pare tudo e leia a Página 3**.

A maioria das dores no Aquiles não é urgência. A exceção é a **ruptura** do tendão. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure atendimento HOJE se:

- Você sentiu um **estalo**, ou a sensação de ter levado uma "**pedrada**" ou **um chute na batata da perna**, seguido de dor e fraqueza. É a descrição típica da ruptura.
- Você **não consegue ficar na ponta do pé** apoiado só na perna dolorida, ou sente um "**buraco**" no tendão.

Com o tendão rompido, muita gente **ainda consegue andar**, e isso engana. O diagnóstico é feito no exame físico, com testes simples, como apertar a panturrilha [1][2].

Procure atendimento no mesmo dia se:

- A região está **vermelha, quente e inchada**, ou há febre. Precisa de exame (opinião clínica).
- A **panturrilha está dolorida e inchada**, mais grossa que a outra, sobretudo depois de viagem longa, cirurgia ou imobilização. Pode ser **trombose**, um coágulo na veia (opinião clínica).
- A dor começou depois do uso de um **antibiótico do grupo das quinolonas**. Essa classe aumenta o risco de lesão e de ruptura do tendão, mais ainda em idosos e em quem usa corticoide [3][4]. Avise o médico que receitou. Não suspenda nem troque remédio por conta própria.

Um tendão grosso e muito exigido

O tendão de Aquiles liga os músculos da panturrilha ao osso do calcanhar. É ele que empurra o corpo para a frente a cada passo, salto ou corrida.

Tendinopatia: o tendão perdeu tolerância à carga

"Tendinopatia" é o nome da dor com perda de função no tendão por sobrecarga. Não é uma simples "inflamação" que passa com repouso: o tendão muda a estrutura e passa a tolerar menos carga [5]. Por isso o nome antigo, "tendinite", vem sendo deixado de lado.

É comum sentir **dor e rigidez ao levantar da cama** ou depois de ficar parado [5].

Dois lugares, dois cuidados

Porção média. Dor, às vezes com um engrossamento, **de 2 a 6 cm acima do calcanhar**, no meio do tendão. É o tipo mais comum [5].

Inserção. Dor **no ponto em que o tendão entra no osso do calcanhar**, às vezes com um "calombo" ósseo atrás. É cerca de 1 em cada 4 ou 5 casos [5]. Aqui, alongar ou deixar o calcanhar descer abaixo do nível do degrau costuma piorar a dor, e o exercício é adaptado [5][12].

Mesmo tendão, lugares diferentes, exercícios diferentes.

O gatilho mais comum: carga que subiu rápido demais

Em atletas com tendinopatia do Aquiles, a maioria relata um **aumento brusco** de volume ou de intensidade do treino antes de a dor começar [5]. Fora do esporte, mudança de rotina, de calçado ou de peso também pode pesar (opinião clínica).

Parar tudo não ensina o tendão a aguentar carga

Num estudo randomizado, 38 pessoas com tendinopatia do Aquiles fizeram o mesmo programa de exercícios. Metade **continuou correndo e saltando**, guiada pela dor. A outra metade **parou** essas atividades por 6 semanas. Em 1 ano, os dois grupos melhoraram, sem diferença entre eles e **sem prejuízo** para quem continuou ativo [8].

Uma revisão de 29 estudos randomizados concluiu que **"esperar para ver" não é recomendado**: os tratamentos ativos foram melhores em 3 meses [11]. Num desses estudos, 24% de quem só esperou relatou melhora em 4 meses, contra 60% de quem fez exercício [14].

Ajustar, e não parar

Ajustar é reduzir o que mais dói (ladeira, tiro de velocidade, salto), manter o que é tolerável e reintroduzir o resto aos poucos [5][8].

Repouso relativo, e não absoluto.

O que os estudos mostram

- **1998, Suécia:** 15 atletas amadores com dor crônica no Aquiles fizeram 12 semanas de exercício de descida lenta do calcanhar, com carga. Todos voltaram a correr [6]. Estudo pequeno e sem sorteio, mas mudou o tratamento.
- **2015, Dinamarca:** num ensaio randomizado, o **exercício lento e pesado** teve resultado tão bom quanto o de descida lenta [7]. O que importa é a carga progressiva, e não um exercício "mágico".
- **Diretriz:** a diretriz americana de fisioterapia ortopédica (2018, revista em 2024) coloca o exercício de carga como **primeira linha**, com o grau mais alto de recomendação [9][10].

Honestidade: entre os tratamentos ativos, uma revisão de 29 ensaios não encontrou diferença relevante, com certeza baixa ou muito baixa [11]. O exercício é a base porque funciona, é seguro e fica nas suas mãos. Não é garantia.

A regra da dor

Modelo criado por pesquisadores suecos e testado em ensaio randomizado [8]:

- Dor **até 5**, numa escala de 0 a 10, durante e logo depois da atividade.
- A dor **volta ao seu normal até a manhã seguinte**.
- Dor e rigidez **não aumentam de uma semana para a outra**.

Falhou uma regra? Reduza a carga naquela semana.

A escolha destes três é opinião clínica, inspirada nos programas dos estudos [6][7], que tinham acompanhamento profissional. Este guia não substitui essa orientação.

Dor na inserção: faça tudo **no chão plano**, sem deixar o calcanhar descer abaixo do nível do pé [5][12].

Exercício 1 — Subida dos calcanhares com os dois pés

Como fazer: de pé, apoiado na parede ou no corrimão, pés na largura do quadril. Suba na ponta dos pés em 2 segundos e desça em 3. 3 séries de 10 a 15.

Sensação correta: esforço na batata da perna. Incômodo leve no tendão é aceitável (Página 6).

Erro comum: subir com impulso ou jogar o peso para a borda de fora do pé.

Exercício 2 — Descida lenta com uma perna

Como fazer: suba com os dois pés, tire o pé bom do apoio e **desça devagar só com a perna dolorida**, contando 3 a 4 segundos. Volte a subir com os dois. 3 séries de 8 a 15, com o joelho esticado e depois levemente dobrado.

Sensação correta: a panturrilha "segurando" a descida.

Erro comum: despencar no final do movimento.

Exercício 3 — Subida dos calcanhares sentado

Como fazer: sentado, joelhos dobrados, pés no chão e uma mochila com peso sobre as coxas. Suba os calcanhares e desça devagar. 3 séries de 10 a 15.

Sensação correta: esforço na parte de baixo da panturrilha.

Erro comum: começar com peso demais.

Semanas 1 e 2 — Acalmar e começar

- Exercícios 1 e 3, em dias alternados.
- Reduza o que mais dói. Caminhe dentro da regra da dor.

Semanas 3 a 6 — Fortalecer

- Exercícios 1, 2 e 3, em dias alternados.
- Progrida **uma coisa de cada vez**: Exercício 1 com uma perna só, depois mochila nas costas.

Semanas 7 a 12 — Construir e voltar

- Mais peso na mochila, se a regra da dor permitir.
- Volta gradual: caminhada rápida, depois trote, depois corrida e salto.

Volumes e prazos são um ponto de partida prático, e não um protocolo testado. Doze semanas são o começo: a recuperação completa pode levar um ano ou mais [5][6].

Rastreador

	Rigidez ao acordar (0–10)	Dor máx. no exercício (0–10)	Normal na manhã seguinte? (S/N)	Sessões feitas	Estalo ou perda de força? (S/N)
Semanas 1–2					
Semanas 3–4					
Semanas 5–6					
Semanas 7–8					
Semanas 9–10					
Semanas 11–12					

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra a tendência, e não só o pior dia.

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Isso é decisão tomada na consulta.

Uso vários desses recursos no consultório. Por isso mesmo, digo o que a evidência sustenta e o que não sustenta.

Calçado, palmilha e calço no calcanhar

Evidência **limitada e contraditória** [5][11]. Palmilha sob medida não se mostrou melhor que a pronta [5]. Um calço pequeno no calcanhar pode aliviar por um tempo, sobretudo na dor de inserção [5]. É complemento, e não tratamento.

Ondas de choque

Evidência **moderada e variável**. Na porção média, o resultado foi parecido com o do exercício [14]. Na inserção, foi melhor que o exercício isolado, num estudo do mesmo grupo de pesquisadores [15]. Os resultados variam entre estudos [5][11]. Pode entrar como **complemento** do exercício, caso a caso.

Infiltração de corticoide no tendão

Não é recomendada. O alívio, quando aparece, é curto e se perde com o tempo [16]. Em animais, a injeção dentro do tendão o enfraqueceu, e há relatos de ruptura em pessoas [17]. Nos estudos controlados, a ruptura foi rara [16]. Mesmo assim, num tendão que carrega o peso do corpo, o risco não compensa (opinião clínica).

Outras injeções e cirurgia

Não há evidência que sustente injeções, sozinhas ou junto com o exercício [5]. A cirurgia é exceção, considerada quando meses de tratamento bem feito não resolveram (opinião clínica).

1. Parar tudo e esperar passar.

Repouso total não ensina o tendão a aguentar carga, e "esperar para ver" teve resultado pior que tratar [8][11][14].

2. Voltar ao treino de antes assim que a dor alivia.

A recaída é comum, principalmente quando a volta é apressada [5]. Melhorar a dor não é o mesmo que recuperar a força.

3. Alongar com força ou descer do degrau na dor de inserção.

Na inserção, isso aperta o tendão contra o osso e costuma piorar. O exercício é feito no chão plano [5][12].

4. Pedir uma infiltração "para resolver rápido".

O alívio do corticoide é passageiro, e o tendão pode ficar mais frágil [16][17].

5. Desistir do exercício em duas semanas.

Os estudos medem resultado em meses [6][7]. Num acompanhamento de 5 anos, 80% das pessoas tratadas só com exercício se recuperaram por completo, e 20% seguiam com sintomas [13].

Bônus: achar que um estalo atrás da perna é "só tendinite".

Estalo seguido de fraqueza é suspeita de ruptura até prova em contrário (Página 3) [1].

Procure avaliação se:

- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.
- **Não há melhora clara após 6 a 8 semanas** de exercício bem feito.
- A dor atrapalha **andar, trabalhar ou dormir** na maioria dos dias.
- A dor aparece **nos dois tendões** ou junto com dor e inchaço em outras articulações. Doenças inflamatórias também podem começar assim [5].
- Você tem dúvida se a dor é no meio do tendão ou na inserção.

O prazo de 6 a 8 semanas é bom senso clínico, e não uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: onde dói, se há engrossamento, a força para ficar na ponta do pé e os testes que ajudam a **diferenciar tendinopatia de ruptura** [1][2]. Outras causas de dor atrás do tornozelo também entram na conta [5]. Ultrassom ou ressonância, quando vão mudar a conduta (opinião clínica). Só depois se decide o tratamento, junto com você.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Chiodo CP, Glazebrook M, Bluman EM, Cohen BE, et al. **Diagnosis and treatment of acute Achilles tendon rupture.** J Am Acad Orthop Surg. 2010;18(8):503-510. doi:10.5435/00124635-201008000-00007. PMID: 20675643.
2. Maffulli N. **The clinical diagnosis of subcutaneous tear of the Achilles tendon. A prospective study in 174 patients.** Am J Sports Med. 1998;26(2):266-270. doi:10.1177/03635465980260021801. PMID: 9548122.
3. van der Linden PD, Sturkenboom MC, Herings RM, Leufkens HM, et al. **Increased risk of achilles tendon rupture with quinolone antibacterial use, especially in elderly patients taking oral corticosteroids.** Arch Intern Med. 2003;163(15):1801-1807. doi:10.1001/archinte.163.15.1801. PMID: 12912715.
4. Stephenson AL, Wu W, Cortes D, Rochon PA. **Tendon injury and fluoroquinolone use: a systematic review.** Drug Saf. 2013;36(9):709-721. doi:10.1007/s40264-013-0089-8. PMID: 23888427.
5. Silbernagel KG, Hanlon S, Sprague A. **Current clinical concepts: conservative management of Achilles tendinopathy.** J Athl Train. 2020;55(5):438-447. doi:10.4085/1062-6050-356-19. PMID: 32267723.
6. Alfredson H, Pietilä T, Jonsson P, Lorentzon R. **Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis.** Am J Sports Med. 1998;26(3):360-366. doi:10.1177/03635465980260030301. PMID: 9617396.
7. Beyer R, Kongsgaard M, Hougs Kjær B, Øhlenschläger T, et al. **Heavy slow resistance versus eccentric training as treatment for Achilles tendinopathy: a randomized controlled trial.** Am J Sports Med. 2015;43(7):1704-1711. doi:10.1177/0363546515584760. PMID: 26018970.
8. Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. **Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study.** Am J Sports Med. 2007;35(6):897-906. doi:10.1177/0363546506298279. PMID: 17307888.
9. Martin RL, Chimenti R, Cuddeford T, Houck J, et al. **Achilles pain, stiffness, and muscle power deficits: midportion Achilles tendinopathy revision 2018.** J Orthop Sports Phys Ther. 2018;48(5):A1-A38. doi:10.2519/jospt.2018.0302. PMID: 29712543.
10. Chimenti RL, Neville C, Houck J, Cuddeford T, et al. **Achilles pain, stiffness, and muscle power deficits: midportion Achilles tendinopathy revision – 2024.** J Orthop Sports Phys Ther. 2024;54(12):CPG1-CPG32. doi:10.2519/jospt.2024.0302. PMID: 39611662.
11. van der Vlist AC, Winters M, Weir A, Arden CL, et al. **Which treatment is most effective for patients with Achilles tendinopathy? A living systematic review with network meta-analysis of 29 randomised controlled trials.** Br J Sports Med. 2021;55(5):249-256. doi:10.1136/bjsports-2019-101872. PMID: 32522732.
12. Jonsson P, Alfredson H, Sunding K, Fahlström M, Cook J. **New regimen for eccentric calf-muscle training in patients with chronic insertional Achilles tendinopathy: results of a pilot study.** Br J Sports Med. 2008;42(9):746-749. doi:10.1136/bjsm.2007.039545. PMID: 18184750.
13. Silbernagel KG, Brorsson A, Lundberg M. **The majority of patients with Achilles tendinopathy recover fully when treated with exercise alone: a 5-year follow-up.** Am J Sports Med. 2011;39(3):607-613. doi:10.1177/0363546510384789. PMID: 21084657.
14. Rompe JD, Nafe B, Furia JP, Maffulli N. **Eccentric loading, shock-wave treatment, or a wait-and-see policy for tendinopathy of the main body of tendo Achillis: a randomized controlled trial.** Am J Sports Med. 2007;35(3):374-383. doi:10.1177/0363546506295940. PMID: 17244902.
15. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. **Eccentric loading compared with shock wave treatment for chronic insertional Achilles tendinopathy. A randomized, controlled trial.** J Bone Joint Surg Am. 2008;90(1):52-61. doi:10.2106/JBJS.F.01494. PMID: 18171957.
16. Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. **Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials.** Lancet. 2010;376(9754):1751-1767. doi:10.1016/S0140-6736(10)61160-9. PMID: 20970844.
17. Shrier I, Matheson GO, Kohl HW 3rd. **Achilles tendonitis: are corticosteroid injections useful or harmful?** Clin J Sport Med. 1996;6(4):245-250. PMID: 8894337.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

